

Nr. 222 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage einer Reichsärzteordnung. 7. September 1935*R 43 II/735a, Bl. 47–49 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die nationalsozialistische Regierung hat die Sorge um die geistige, seelische und körperliche Ertüchtigung des Volkes in den Vordergrund der innerpolitischen Ziele gerückt. Weit mehr als früher gibt die Rücksicht auf das Gedeihen des Volkskörpers als einer lebendigen Einheit den staatlichen Maßnahmen Inhalt und Richtung. Dabei gilt es nicht nur vielfache Mißstände aus vergangener Zeit zu beseitigen. Auch beschränkt sich die Gesundheitspolitik nicht auf die Förderung der Volksgesundheit im engeren Sinne, sondern sie stellt darüber hinaus die Erhaltung und Hebung des Erbgutes und der Rasse des deutschen Volkes in den Mittelpunkt ihres Strebens. Bei jedweder Gesundheitsfürsorge ist der Blick über den kranken Einzelmenschen hinaus auf die blutsverbundene Volksgemeinschaft gerichtet.

Die Durchführung dieser volkspflegerischen Aufgaben erfordert die verständnisvolle und tatkräftige Mitarbeit der Ärzteschaft. Bei dem Ringen um die Zukunft des deutschen Volkes liegt dem Arzt nicht nur die Behebung gesundheitlicher Störungen ob. Er hat mit all seinem beruflichen Können und seiner großen Einflußmöglichkeit dahin zu wirken, daß dem deutschen Volk ein zahlreicher, erbgesunder Nachwuchs ersteht.

Die Erfüllung solcher Erwartungen setzt voraus, daß ein in jeder Beziehung hochstehender, der Bedeutung seiner Aufgaben bewußter Ärztestand vorhanden ist. Dazu bedarf es auch einer Stan-

¹ Mit GesEntw. und Einzelbegründung (R 43 II/735a, Bl. 28–64) auch überliefert in: R 18/5573, S. 325–398. – Eine reichseinheitliche Standesordnung der Ärzte war von den ärztlichen Berufsvertretungen (Dt. Ärztevereinsbund und Verband der Ärzte Dtl. – Hartmannbund) bereits während der Weimarer Republik vergeblich angestrebt worden, damals mit dem Hauptziel, den Arztberuf über die Festlegung verbindlicher berufsethischer Normen scharf vom Heilpraktikerwesen und Kurpfuschertum abzugrenzen, ihn damit aus der Sphäre der Gewerbeordnung, der er bislang unterstand, herauszulösen und schließlich auch das ungeklärte Verhältnis zum Staat durch Schaffung einer selbstverwalteten Standesvertretung öffentlich-rechtlicher Natur zu regeln. Der erste Entwurf einer Reichsärzteordnung (RÄO) nach der Machtergreifung datierte vom Juni 1933; R 1501/26404, Bl. 95–142. Er war aufgestellt vom Nat.-soz. Dt. Ärztebund (NSDÄB) gemeinsam mit dem Ärztevereins- und dem Hartmannbund, die beide mittlerweile unter der kommissarischen Leitung des NSDÄB-Führers Gerhard Wagner gleichgeschaltet waren; Wagner wurde seither als „Reichsärzteführer“ (RÄF) titulierte. Im Herbst 1933 zog das RIM die Entwurfsarbeiten an sich, eine erste Referentenfassung der RÄO wurde am 13. 3. 34 einer eingehenden Besprechung der Ressorts unterzogen; R 1501/26404, Bl. 145–212, 298–317. Die weiteren Arbeiten litten am zunehmenden Kompetenzgerangel zwischen RIM und RÄF/StdF. Umstritten war v. a. die Frage, ob auch beamtete Ärzte Zwangsglieder der Reichsärztekammer werden müßten, was RIM und RFM wegen der Unterstellung unter eine doppelte Disziplinargewalt zunächst ablehnten, Wagner aber schließlich durchsetzte; nur die Sanitäts-offiziere der Wehrmacht blieben ausgenommen. Den Hauptstreitpunkt aber bildete die Befugnis zur Ernennung und Entlassung des Leiters der Reichsärztekammer, die der RIM für sich beanspruchte, und zwar nach dem ursprünglichen Willen Fricks nur „nach Anhören“, nicht „im Einvernehmen“ mit dem StdF; R 1501/26404, Bl. 31, 215, 219–255. Demgegenüber forderte Wagner, der als Chef der Reichsärztekammer in Aussicht genommen war und dem RIM generell die Leitung des Gesundheitswesens streitig machte, seine Ernennung durch Hitler persönlich, da er ansonsten als RÄF „von diesem Ministerium [RIM] abhängig und sowohl den anderen Ressorts, besonders auch der Partei gegenüber, unselbständig“ bliebe; s. Eingaben Wagners an StdF vom 16. 1. und 19. 2. 35: R 43 II/735a, Bl. 2–11, 13–16. Im Juni 1934 bereits hatte StS Pfundtner den Entwurf der RÄO kabinettsreif geglaubt, am 24. 6. 35 vermerkte er resigniert zum Sachstand: Die über einjährige Verzögerung sei ausschließlich durch RÄF und StdF veranlaßt, welche nach aufwendigen, im März 1935 zum Abschluß gelangten Verhandlungen wieder zahlreiche neue Änderungswünsche vorgebracht hätten; R 1501/26404, Bl. 31, 219–255; R 18/5573, S. 321 f. Eine Einigung war schließlich nur um den Preis zu erreichen, daß Frick Wagners Forderungen nachgab. Entwurfsarbeiten und -fassungen 1934/35 s. R 1501/26404, Bl. 319–389, 408–420; R 18/573, Bl. 136 ff.; R 18/5573, passim. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30316; speziell HEYDER, Reichsärzteordnung, S. 34–65.

desorganisation, die bei straffer Gliederung unter Wahrung eines berufsfreudigen freien Arztiums die Verwirklichung der Anforderungen gewährleistet.

Die geltende gesetzliche Regelung der Rechtsverhältnisse des ärztlichen Berufes ist unbefriedigend. Verstreut in der Prüfungsordnung für Ärzte, in der Reichsgewerbeordnung und im Reichsstrafgesetzbuch finden sich Bestimmungen über die Erteilung und Entziehung der Approbation sowie über Einzelheiten der ärztlichen Berufsausübung². In diesen Vorschriften kommen gegenüber der Wahrung subjektiver Individualrechte des einzelnen die höher stehenden Belange der Allgemeinheit vielfach zu kurz. Zwar hat sich daneben im Laufe der Zeit durch die Rechtsprechung der ärztlichen Ehrengerichte ein ungeschriebenes ärztliches Standes- und Berufsrecht entwickelt. Bei der kasuistischen Art seiner Entstehung ist dieses Recht jedoch lückenhaft. Es fehlt daher sowohl sachlich als formell an einer zusammenfassenden, die großen leitenden Grundsätze systematisch durchführenden erschöpfenden Regelung. Was insbesondere die Standesorganisation betrifft, so sind zwar durchweg nach Landesrecht öffentlich-rechtliche Berufsvertretungen vorhanden, denen neben der Wahrnehmung und Vertretung der Interessen des Ärztestandes auch die Sorge um allgemeine Fragen der Volksgesundheit und der ärztlichen Berufsausübung obliegt, aber sie vermögen weder in ihrem Aufbau noch in der Art ihrer Willensbildung und Zielsetzung den Anforderungen des neuen Staates zu genügen. Überdies fehlt ihnen die zusammenfassende einheitliche Spitze für das ganze Reich.

Der vorliegende Entwurf einer Reichsärzteordnung will hierin Wandel schaffen.

Der Entwurf regelt im *ersten Abschnitt* die Berufsverhältnisse des Arztes. Er beschränkt sich dabei auf das, was staatlicherseits geordnet werden muß, und überläßt es der neu zu bildenden Reichsärztekammer als der obersten Vertreterin der deutschen Ärzteschaft, die sonst erforderliche allgemeine Regelung in einer Berufsordnung zu treffen (§ 14 des Entwurfs). Zur Sicherung des staatlichen Einflusses ist das Erfordernis der Zustimmung des Reichsministers des Innern zu dieser Berufsordnung vorgesehen.

Das Kernstück des Entwurfs bildet im *zweiten Abschnitt* der berufsständische Aufbau der deutschen Ärzteschaft und die Bestimmung ihrer Aufgaben, die Festsetzung ihrer Pflichten und Rechte. Es handelt sich hierbei um ein völlig neues ärztliches Organisationsrecht. Richtschnur für die Regelung all dieser Fragen ist der im nationalsozialistischen Staat zu neuem Leben erwachte berufsständische Gedanke. Auf dieser Grundlage ergibt sich von selbst die berufsständische Eingliederung der Ärzteschaft als einer realverbundenen Gemeinschaft in den Staat. Das Ziel ist also nicht die Schaffung einer bloßen Berufsvertretung, sondern die Bildung eines in das staatliche Dasein einbezogenen, zur Mitwirkung an den Aufgaben des Staates berufenen Organismus. Diese Neugestaltung will die Ärzteschaft als Ganzes aus einem staatlich überwachten Träger individueller Betätigung in einen Träger öffentlicher Aufgaben verwandeln³. Gerade die Möglichkeit einer Mitwirkung an den staatlichen Aufgaben, für die innerhalb des ärztlichen Berufs ein reiches Betätigungsfeld gegeben ist, soll den Berufsstand vor der Gefahr bewahren, in die Stellung einer einseitigen Berufsvertretung abgedrängt zu werden.

² In der Reichsgewerbeordnung insbesondere § 29 (Erteilung der Approbation), § 53 Abs. 1 (Entzug der Approbation), § 80 Abs. 2 (Arzthonorare), § 147 Nr. 3 (Titelanmaßung); im StGB § 300 (ärztliche Schweigepflicht); ferner die Prüfungsordnung für Ärzte vom 5. 7. 24 (RMinBl. S. 240) i.d.F. der Änderung vom 6. 2. 35 (RMinBl. S. 65).

³ Vgl. § 19: „Die deutsche Ärzteschaft ist berufen, zum Wohle von Volk und Reich für die Erhaltung und Hebung der Gesundheit, des Erbguts und der Rasse des deutschen Volkes zu wirken.“ § 20: „Die Reichsärztekammer ist die Vertretung der deutschen Ärzteschaft. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. [...]“

§ 21: „(1) Der Leiter der Reichsärztekammer (Reichsärzteführer) nimmt die Befugnisse der Reichsärztekammer wahr und vertritt die Reichsärztekammer gerichtlich und außergerichtlich. Er hat einen ständigen Stellvertreter. Er kann auch andere Personen mit seiner Vertretung in einzelnen Aufgabengebieten oder mit der Wahrnehmung einzelner Befugnisse betrauen.

(2) Der Leiter der Reichsärztekammer wird vom Führer und Reichskanzler ernannt und abberufen. Die Ernennung und Abberufung erfolgt auf Vorschlag des Reichsministers des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers. [...]“

Das Wesen eines so gedachten Berufsstandes als einer realen Gemeinschaft verträgt naturgemäß nicht eine Absonderung einzelner Teile. Deshalb ist der Grundsatz befolgt, daß die Zugehörigkeit eines jeden Arztes zu der Gemeinschaft ohne weiteres gegeben ist⁴.

In der Regelung der Befugnisse der ärztlichen berufsständischen Körperschaft kommt vor allem das Zurücktreten des Einzelinteresses klar zum Ausdruck. Der Einzelwille soll dem Willen der Gemeinschaft untergeordnet sein. Diesem Gedanken entspricht es, daß der Reichsärztekammer auch ein maßgeblicher Einfluß auf den Inhalt der Verträge eingeräumt wird, durch die ein Arzt in der öffentlichen Gesundheitspflege die ärztliche Behandlung übernimmt, und daß sie Ärzte zur Erfüllung von *ihr* geschlossener Verträge dieser Art verpflichten kann (§§ 48, 49 des Entwurfs)⁵.

In den Vorschriften über die Willensbildung innerhalb der ärztlichen berufsständischen Organisationen wird der Entwurf dem nationalsozialistischen Führerprinzip gerecht. Der Wille des Leiters wird als das Wollen der gesamten Gemeinschaft anerkannt. Durch den Leiter wird das Handeln bestimmt. Freilich darf er nicht völlig darauf verzichten, die Auffassung der anderen berufsständischen Organe anzuhören; niemals aber wird er durch deren Stellungnahme gehemmt⁶.

Der *dritte Abschnitt* des Entwurfs behandelt die Bestrafung ärztlicher Berufsvergehen. Für die Verhängung niedriger Strafen soll auch die Reichsärztekammer zuständig sein, während der Entwurf den Ausspruch höherer Strafen allein den ärztlichen Berufsgerichten vorbehält. Die Regelung des Verfahrens und des Rechtszuges bei den ärztlichen Berufsgerichten entspricht im wesentlichen derjenigen in den geltenden landesrechtlichen Ehrengerichtsordnungen für die Ärzte. Neu ist im Strafsystem der Ausschluß von der weiteren behandelnden Tätigkeit in der öffentlichen Gesundheitspflege, der auf Zeit oder für die Dauer stattfinden kann, und die Feststellung des ärztlichen Berufsgerichts, daß der Beschuldigte unwürdig ist, den ärztlichen Beruf auszuüben (§ 52). Daß der Entwurf für den Fall der Verhängung der letztgenannten Strafe die Zurücknahme der ärztlichen Bestallung anordnet, erscheint im Hinblick auf die Bedeutung des berufsständischen Lebens und Handelns geboten.

Der Entwurf weist in seinem *vierten Abschnitt* den staatlichen Behörden das Maß an Aufsichts-befugnis zu, das den staatlichen Bedürfnissen entspricht. So sieht er vor, daß die Aufsichts-behörde⁷ Entschließungen oder Anordnungen der Reichsärztekammer oder ihrer Untergliederungen aufheben kann, wenn sie dem bestehenden Recht oder den Zielen der Staatsführung zuwiderlaufen, und daß sie die Rückgängigmachung von Maßnahmen fordern kann, die aufgrund derartiger Entschließungen oder Anordnungen getroffen waren.

Der *fünfte Abschnitt* des Entwurfs enthält neben den notwendigen Schlußbestimmungen im wesentlichen Vorschriften, die der Überleitung der bestehenden ärztlichen Körperschaften, Standesvereine, wirtschaftlichen Verbände und Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen in die berufsständische Körperschaft dienen. Es würde dem im Entwurf verwirklichten Grundgedanken

⁴ Dies bezog sich auch auf Amtsärzte und, entgegen dem Willen des RErzM, auf medizinische Universitätsprofessoren; s. § 25: „(1) Der Reichsärztekammer unterstehen alle Ärzte im Deutschen Reich.

(2) Für Ärzte, die im Sanitätsdienst der Wehrmacht stehen, ruht die Unterstellung unter die Reichsärztekammer für die Dauer ihrer Dienstleistung.“

⁵ Nach § 48 war allein die Reichsärztekammer berechtigt, mit den Trägern der öffentl. Fürsorge und der Reichsversorgung Verträge über die Tätigkeit freiberuflicher Ärzte abzuschließen. § 49: „(1) Soweit die Reichsärztekammer die ärztliche Versorgung in der öffentlichen Gesundheitspflege oder bei Einrichtungen, die dem öffentlichen Wohl dienen, übernimmt, kann sie Ärzte zur Teilnahme verpflichten.

(2) Die Reichsärztekammer kann mit Genehmigung des Reichsministers des Innern für die Ärzte verbindliche Vorschriften über Verträge erlassen, durch die ein einzelner Arzt oder mehrere Ärzte in der öffentlichen Gesundheitspflege oder bei nichtöffentlichen Einrichtungen die ärztliche Behandlung übernehmen; [...]“

⁶ Vgl. o. Anm. 3 (§ 21), außerdem § 22:

„(1) Dem Leiter der Reichsärztekammer steht ein Beirat zur Seite, dessen Mitglieder von ihm ernannt und abberufen werden.

(2) Der Beirat hat den Leiter der Reichsärztekammer zu beraten und zu unterstützen. Er ist vor der Entscheidung in wichtigen Angelegenheiten zu hören.“

⁷ Der RIM (§ 80).

widersprechen, wollte man sonstige ärztliche Standesvertretungen und vor allem die verschiedenen ärztlichen Vereinigungen privater Natur weiterbestehen lassen⁸.

Im ganzen läßt sich das Ziel des Entwurfs kurz dahin kennzeichnen, daß er den Ärztestand als einen der Volksgemeinschaft und dem Staate dienenden besonderen Stand ausgestalten will, der so einwandfrei und stark dasteht, wie es zum Wohle von Volk und Reich notwendig ist. Der Entwurf wahrt das freie Arzttum, unterstellt jedoch den einzelnen der Führung seiner Standesorganisation, dies letzten Endes nicht mit der Wirkung eines lästigen Zwanges, sondern im Sinne einer richtig verstandenen Freiheit im Dienste des Volkes.

[...]⁹

⁸ Rechtsnachfolger des Dt. Ärztevereinsbundes e.V. in Potsdam wurde die Reichsärztekammer, die des Verbands der Ärzte Dtls. (Hartmannbund) in Leipzig die Kassenärztliche Vereinigung Dtls. (§ 87).

⁹ Folgt: Einzelbegründung. – Nach einer Reihe kritischer Ressortstellungnahmen, die insbesondere die Berufung der Beiratsmitglieder durch den RÄF selbst, die Monopolisierung der ärztlichen Haftpflichtversicherung sowie den Zwangsbeitritt auch der beamteten Mediziner einschl. Universitätsprofessoren zur Ärztekammer betrafen (R43 II/735a, Bl. 65–78, 106 f.), legte der RIM am 15. 10. 35 dem StSRk eine (geringfügig) überarbeitete Neufassung der RÄO vor, die jedoch nach Entscheidung Hitlers nicht wie beantragt kurzfristig auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 18. 10. kam; ebd. Bl. 79–103. Die endgültige Fassung wurde nach einer Reihe weiterer Änderungen, welche die Ärzteschaft auch den Nürnberger Rassenbestimmungen unterwarfen, der Rkai am 11. 12. 35 zugestellt und in der Kabinettsitzung vom 13. 12. 35 verabschiedet: Dok. Nr. 282 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 222 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage einer Reichsärzteordnung. 7. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d222>